

2025 年 04 月 28 日

抑郁/癫痫新药需求突出，建议关注华纳药厂/海南海药

投资评级：看好（维持）

——医药行业周报（25/4/21-25/4/25）

投资要点：

证券分析师

刘闯
SAC: S1350524030002
liuchuang@huayuanstock.com
李强
SAC: S1350524040001
liqiang01@huayuanstock.com

联系人

板块表现：



- 本周医药市场表现分析：**4月21日至4月25日，医药指数上涨1.16%，相对沪深300指数超额收益为0.77%。本周创新药板块依旧活跃，舒泰神、迪哲医药、荣昌生物等表现较好，一季报陆续来临，Q1业绩关注度逐步提升，甘李药业、何氏眼科、海泰新光等Q1业绩较好，股价表现亮眼。建议关注：1）创新药出海不受关税影响，继续重点推荐A股信立泰、科伦药业、热景生物、一品红、科兴制药、恒瑞医药；港股三生制药、科伦博泰、康方生物、中国生物制药；2）Q1业绩较好或者利空落地的个股，建议关注开立医疗、迈瑞医疗、鱼跃医疗、麦澜德、海泰新光、长春高新等；3）关注消费类资产，中药（华润三九、东阿阿胶、昆药集团、健民集团、马应龙），家用器械（三诺生物、可孚医疗）。
- 医药指数和各细分领域表现、涨跌幅：**本周医药指数上涨1.16%，上涨个股数量311家，下跌个股174家，涨幅居前为永安药业（+31.37%）、舒泰神（+28.41%）、尔康制药（+27.73%）、富士莱（+23.89%）和卫信康（+21.00%），跌幅居前为*ST吉药（-43.24%）、南华生物（-35.29%）、双成药业（-27.74%）、荣丰控股（-21.24%）和爱博医疗（-19.07%）。
- 癫痫为中枢神经领域大病种，临床上存在较大未满足需求，海外临床三期创新产品市场估值近30亿美元，建议关注海南海药：**全球约有5170万癫痫患者，中国约有900万癫痫患者，当前癫痫药物主要以传统药物为主，且有30%难治性癫痫患者对现有药物不敏感，样本医院显示2023年国内抗癫痫药市场规模超50亿元（我们预计实际规模或在百亿量级）。创新药方面，钾离子通道KCNQ家族因关键调控作用在癫痫领域备受关注，也是目前癫痫新药研发最前沿主流方向之一（目前适应症也向抑郁症扩展），且成药性已经得到验证（瑞替加滨），全球来看，Xenon公司（股票代码：XENE.O）新一代KCNQ通道激动剂Azetukalner癫痫适应症已经进入临床3期，其2b期临床数据展示出较为优异的有效性和安全性趋势，且重度抑郁适应症已经进入三期临床，Xenon公司目前仅有Azetukalner一款药物进入临床阶段，截至2025年4月27日，Xenon市值约29亿美元（超200亿元）。在研格局方面，根据医药魔方数据，海外仅3款KCNQ通道激动剂进入临床、国内仅2款进入临床，竞争格局较为良好。国内方面，2019年，海南海药与上海药物所达成合作，获得派恩加滨在中国大陆范围内权利，目前派恩加滨正在国内开展临床二期、临床进度最快，派恩加滨为药物所自主研发全新一代KCNQ通道激动剂，相比于上一代瑞替加滨，化学性质、活性、药代和安全性特征均显著优化，我们预计未来派恩加滨在癫痫和抑郁症等领域的市场潜力值得期待。
- ZG001 改构自氯胺酮但又无成瘾性，有望颠覆抑郁症治疗格局，建议关注华纳药厂。**抑郁症全球高发。传统抗抑郁药种类繁多，但起效时间长，难以满足患者急救需求。强生的Spravato（艾司氯胺酮）是全球唯一MDSI药物疗法，该产品2024年销售额10亿美金，尚处于高速放量阶段。强生对该药寄予厚望，预期2027年销售额至少30亿美金。华纳药厂的ZG001改构自氯胺酮，同时革除其药物依赖、拟精神病样等严重精神副作用，并在临床前和1期临床得到验证。现阶段，该药物已经进入临床2期，并完成首例入组，有望颠覆抑郁症治疗格局。
- 投资观点及建议关注标的：**展望2025年，我们认为医药板块已经具备多方面的积极发展因素，

基本完成了新旧增长动能转换（创新替代仿制，出海能力提升），具体来看，1）国内创新产业已具规模，一批药企的创新布局迎来收获，恒瑞医药、翰森制药、科伦药业等传统 pharma 已完成创新的华丽转身；2）出海能力持续提升，创新药械的 license out 频频出现，中国企业已成为全球 MNC 非常重视的创新转换来源，重磅交易如科伦博泰、康方生物、百利天恒等。医疗设备、供应链等已在全球范围内占据较高的地位，在欧美发达市场以及新兴市场持续崭露头角，如迈瑞医疗、联影医疗、华大智造等；3）老龄化持续加速，心脑血管、内分泌、骨科等慢性疾病需求持续提升，银发经济长坡厚雪；4）支付端看，医保收支仍在稳健增长，同时医保局积极推动商业保险的发展，构建多层次支付体系；5）AI 浪潮下，医药有望释放新的成长逻辑，短期信心有望显著提升。具体配置方面，建议关注创新药械（业绩/创新拐点的 Pharma 以及临床阶段的高价值资产）、出海（CXO 及科研上游、供应链、医疗器械及高端生物药和制剂）、国产替代（医疗设备和高值耗材）、老龄化及院外消费（家用器械、中药等）、高壁垒行业（血制品、麻药）、AI 医疗，同时建议积极关注估值较低有望修复的优质标的。

- **本周建议关注组合：**信立泰、一品红、华纳药厂、开立医疗、方盛制药；
- **四月建议关注组合：**中国生物制药、三生制药、科伦博泰、科伦药业、一品红、科兴制药、热景生物、人福医药、健民集团、昆药集团。
- **风险提示：**行业竞争加剧风险，政策变化风险，行业需求不及预期风险。

内容目录

1. 癫痫：患病人数千万人量级，新药市场潜力可期	6
2. 伴自杀抑郁症治疗需求尚未满足，新药市场潜力可期	11
2.1. 强生 Spravato：唯一 MDSI 药物治疗，销售峰值至少 30 亿美元	12
2.2. 华纳药厂 ZG001：改构氯胺酮，无成瘾性，有望颠覆抑郁症治疗格局	13
3. 行业观点：坚持创新+出海+老龄化主线，关注国内政策修复	14
4. 风险提示	20

图表目录

图表 1: 新诊断癫痫患者 ASMs 选择基本流程	6
图表 2: 中国常用 ASMs 药物情况	7
图表 3: 2019–2024H1 样本医院/药店抗癫痫药物市场规模	7
图表 4: 2023 年样本医院/药店销售额靠前的抗癫痫药物销售情况及市占率情况 (亿元)	7
图表 5: 不同临床试验瑞替加滨 vs 安慰剂给药 28 天后相比基线癫痫发作频率降低比例情况	8
图表 6: 瑞替加滨和安慰剂相比基线在不同癫痫发作频率降低比例的患者人数占比情况	8
图表 7: Xenon Pharmaceuticals 研发管线情况	8
图表 8: DPB 期和 OLE 期受试者癫痫发作频率降低情况	9
图表 9: 持续 12/24/36 月以上癫痫发作频率 (50%/75%/90%) 降低患者占比 (所有进入 OLE 的患者)	9
图表 10: 持续 12/24/36 月以上癫痫发作频率 (50%/75%/90%) 降低患者占比 (完成 36 个月以上治疗患者)	9
图表 11: 持续 12/24/36 月以上癫痫发作频率降幅达到 100% 患者占比情况	9
图表 12: Xenon Pharmaceuticals 研发管线情况	10
图表 13: 全球治疗癫痫的 KCNQ 通道激动剂研发管线情况	10
图表 14: 中国治疗癫痫的 KCNQ 通道激动剂研发管线情况	10
图表 15: 派恩加滨对比瑞替加滨情况	11
图表 16: 常见抗抑郁药情况一览	12
图表 17: 本周申万医药行业涨幅 Top10	14
图表 18: 本周申万医药行业跌幅 Top10	14
图表 19: 2024 年初至今医药指数表现	15
图表 20: 申万各板块年初至今涨跌幅情况	15
图表 21: 年初至今医药子板块涨跌幅情况	16
图表 22: 本周医药子板块表现情况	16
图表 23: 申万各板块 PE 估值情况 (截至 2025 年 4 月 25 日, 整体 TTM 法)	16
图表 24: 申万医药及沪深 300 PE 估值情况 (截至 2025 年 4 月 25 日, 整体 TTM 法)	17
图表 25: 申万医药各细分板块 PE 估值情况 (截至 2025 年 4 月 25 日, 整体 TTM 法)	17

图表 26: 2024 年初至今医药成交额及占 A 股比例 (万亿)	18
--	----

1. 癫痫：患病人数千万人量级，新药市场潜力可期

癫痫是多种原因导致的脑部神经元高度同步化异常放电所致的临床综合征，临床表现具有发作性、短暂性、重复性和刻板性特点，可表现为感觉、运动、意识、精神、行为、自主神经功能障碍，临床上每次发作或每种发作的过程称为痫性发作。

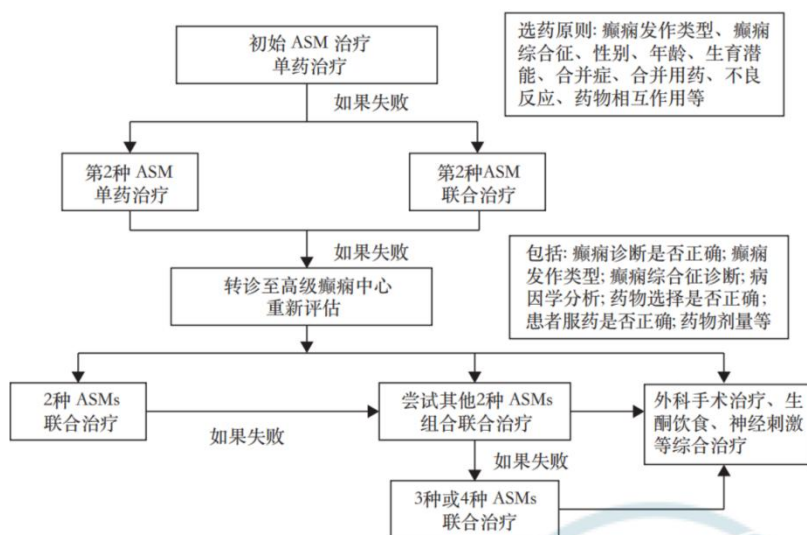
中国约 900 万癫痫患者，其中约 30% 患者对现有药物治疗无效：

癫痫是中枢神经系统常见的慢性疾病之一，根据《柳叶刀-公共卫生》文章《Global, regional, and national burden of epilepsy, 1990–2021: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2021》(GBD Epilepsy Collaborators) 数据，2021 年全球范围内有 5170 万患有癫痫。根据中国抗癫痫协会数据，国内癫痫总体患病率为 7.0‰，约有 900 万左右癫痫患者，其中 600 万是活动性癫痫患者，同时每年新增加癫痫患者约 40 万，中国癫痫患者中有 40.6% 未治疗，35.4% 患者治疗不正规。

根据《抗癫痫发作药物联合使用中国专家共识（2024）》，抗癫痫发作药物（anti-seizure medications, ASMs）是癫痫最重要和最基本的治疗手段，也是癫痫治疗首选，癫痫的药物治疗原则一直强调首选单药治疗，并认为规范且足疗程地使用 2 种或 2 种以上的单药治疗失败后再考虑药物联合应用，或仅在单药治疗未达到无发作效果时才推荐联合用药。

在新确诊癫痫患者中，初始单药治疗可使约 50% 患者达到临床无发作，首次单药治疗失败后，联合药物治疗可以进一步使 20.4% 癫痫患者临床发作得到缓解。**然而，经单药序贯或多药联合治疗后，仍有 30% 的癫痫患者发作无法得到有效控制。**

图表 1：新诊断癫痫患者 ASMs 选择基本流程



资料来源：《抗癫痫发作药物联合使用中国专家共识（2024）》，华源证券研究所

常用 ASMs 包括：钠离子通道阻滞剂、选择性增强电压门控钠通道的慢失活、 γ -氨基丁酸类似物、突触囊泡蛋白 A 结合剂等。

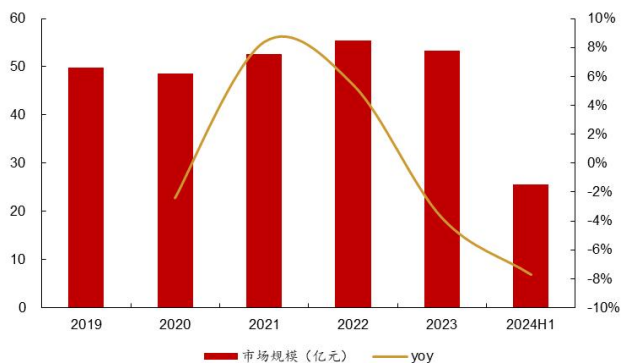
图表 2：中国常用 ASMs 药物情况

药物作用机制	ASMs
钠离子通道阻滞剂	卡马西平、奥卡西平、苯妥英钠、艾司利卡西平
选择性增强电压门控钠通道的慢失活	拉考沙胺
γ -氨基丁酸类似物	氯硝西泮、苯巴比妥、氯巴占、氨己烯酸
突触囊泡蛋白 A 结合剂	左乙拉西坦、布瓦西坦
高选择性非竞争性 AMPA 亚型谷氨酸受体拮抗剂	吡仑帕奈
其他或多种作用机制共存（包括钠离子通道阻滞剂）	丙戊酸、拉莫三嗪、托吡酯、唑尼沙胺、加巴喷丁、普瑞巴林、大麻二酚、氨基甲酸酯、芬氟拉明

资料来源：《抗癫痫发作药物联合使用中国专家共识（2024）》，华源证券研究所

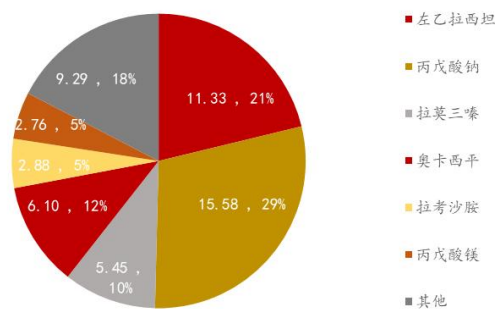
样本医院数据显示，2023 年国内样本医院/药店抗癫痫药物市场规模超过 50 亿元，其中丙戊酸钠销售规模约 15 亿元，左乙拉西坦销售规模约 11 亿元，考虑到样本医院放大，国内实际抗癫痫药物市场我们预计或有百亿量级。

图表 3：2019-2024H1 样本医院/药店抗癫痫药物市场规模



资料来源：米内网，华源证券研究所

图表 4：2023 年样本医院/药店销售额靠前的抗癫痫药物销售情况及市占率情况（亿元）

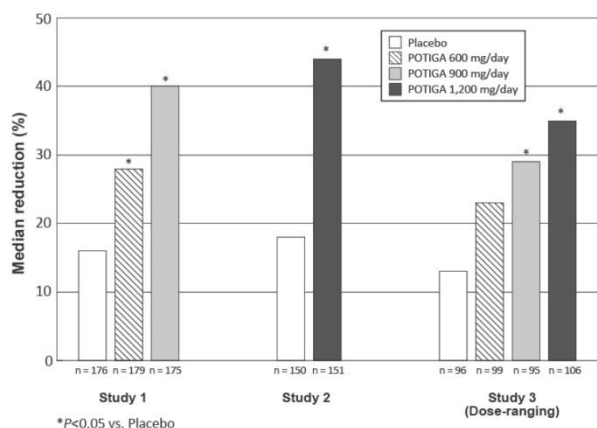


资料来源：米内网，华源证券研究所

KCNQ 基因编码的电压门控钾通道 Kv7，是最早被发现与人类疾病相关的离子通道之一，在许多生理过程中扮演至关重要的角色，包括神经元和肌肉的电信号传导、神经递质和激素分泌、细胞增殖和迁移以及离子稳态，钾离子通道 KCNQ 家族因关键调控作用在癫痫新药研发领域备受关注，也是目前癫痫新药研发最前沿的主流方向之一。

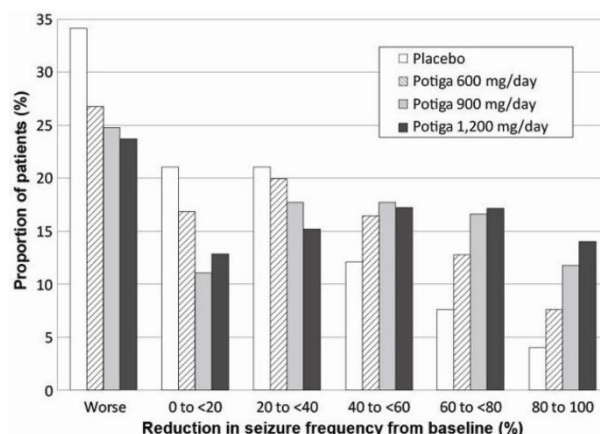
KCNQ 家族包含 Kv7.1-Kv7.5 (KCNQ1-5) 五个亚型，其中 KCNQ2 是确证癫痫治疗靶点，首个靶向 KCNQ2 通道的抗癫痫药物瑞替加滨 (Retigabine, RTG) 于 2011 年上市，从有效率来看，瑞替加滨针对难治性癫痫患者效果显著，在三期临床试验 study 2 中，最高剂量 (1200mg/天) 给药 28 天后癫痫发作频率下降超过 40%，但瑞替加滨存在严重的剂量相关的皮肤及视网膜色素沉积等毒副作用，2016 年被加入黑框警告，GSK 于 2017 年将其主动撤市。

图表 5：不同临床试验瑞替加滨 vs 安慰剂给药 28 天后相比基线癫痫发作频率降低比例情况



资料来源：瑞替加滨 FDA 说明书，华源证券研究所

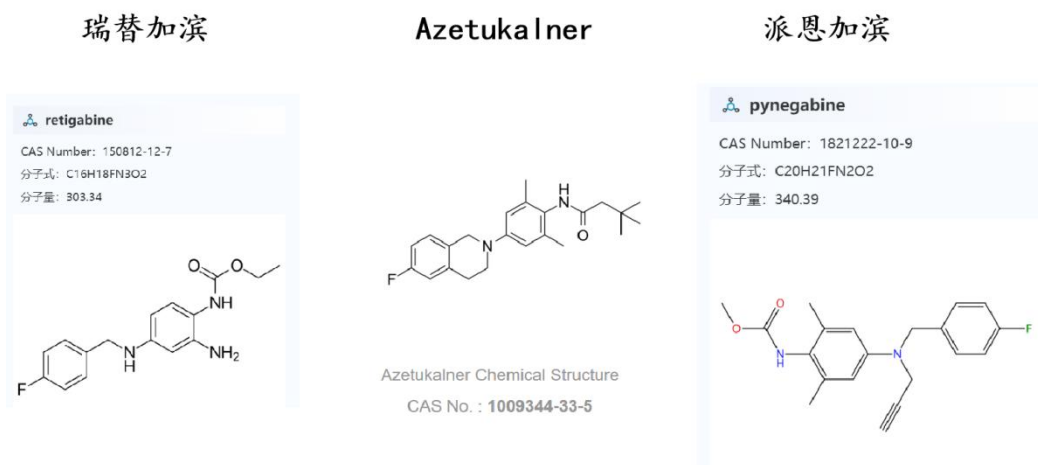
图表 6：瑞替加滨和安慰剂相比基线在不同癫痫发作频率降低比例的患者人数占比情况



资料来源：瑞替加滨 FDA 说明书，华源证券研究所

基于 KCNQ2 靶点在癫痫领域治疗效果的确定性，目前临床上关注开发高效且安全性更好的靶向 KCNQ2 抗癫痫药物。全球来看，目前临床进度最快的是 Xenon Pharmaceuticals（股票代码：XENE.O）公司的 Azetukalner，Azetukalner 是基于瑞替加滨升级的新一代选择性 Kv7 钾通道开放剂，目前癫痫适应症处于临床三期阶段。

图表 7：Xenon Pharmaceuticals 研发管线情况



资料来源：Xenon 公司官网，华源证券研究所

Azetukalner 临床方案：在 2b 临床研究中，针对难治性癫痫患者（接受过 1-3 种抗癫痫药物治疗），试验分为 8 周的双盲期（DPB）和长期随访开放标签期（OLE），对照药为安慰剂，试验共纳入 325 人，共 285 人完成 DBP，共 275 人进入 OLE 期，182 人在 OLE 期接受治疗超 12 个月，165 人在 OLE 期接受治疗超 24 个月，143 人在 OLE 期接受治疗超 12 个月。

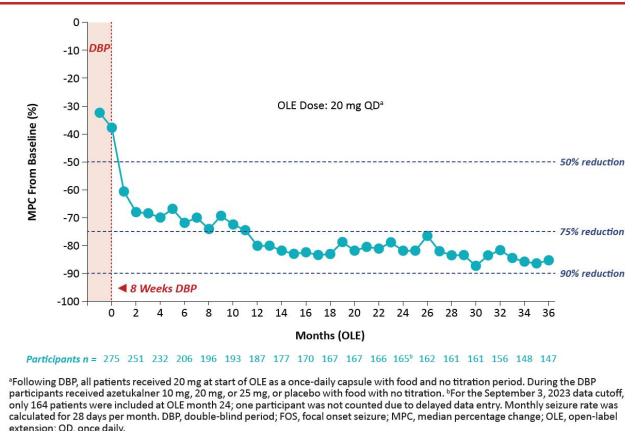
Azetukalner 临床结果：

1) 在开始 OLE 期后，平均癫痫发作频率降幅在 61-82%，给药 36 个月后，癫痫发作频率降幅在 85%；

2) 在持续降低癫痫发作频率方面, Azetukalner 也展示了优良的效果, 如以癫痫发作频率降低 50% 为标准, 所有进入 OLE 期的患者中, 持续 12 月达标的患者比例为 46.9%, 持续 24 个月达标的比例为 29.8%, 持续 36 个月达标的比例为 18.9%; 在给药超过 36 个月的患者中达标率更高, 持续 12 月达标的患者比例为 77.6%, 持续 24 个月达标的比例为 52.4%, 持续 36 个月达标的比例为 35.4%;

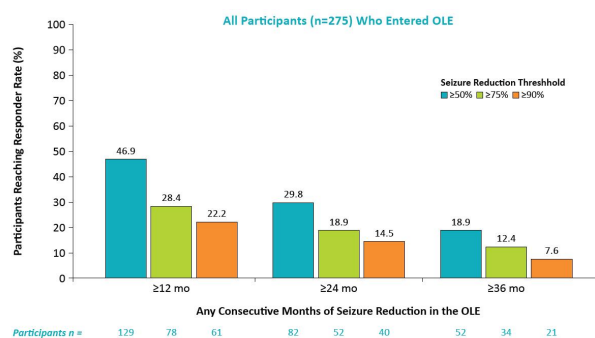
3) 以癫痫未发作为标准, 所有进入 OLE 期的患者中, 持续 12 月达标的患者比例为 18.2%, 持续 24 个月达标的比例为 10.9%, 持续 36 个月达标的比例为 5.5%; 在给药超过 36 个月的患者中达标率更高, 持续 12 月达标的患者比例为 32.7%, 持续 24 个月达标的比例为 20.4%, 持续 36 个月达标的比例为 10.2%;

图表 8: DPB 期和 OLE 期受试者癫痫发作频率降低情况



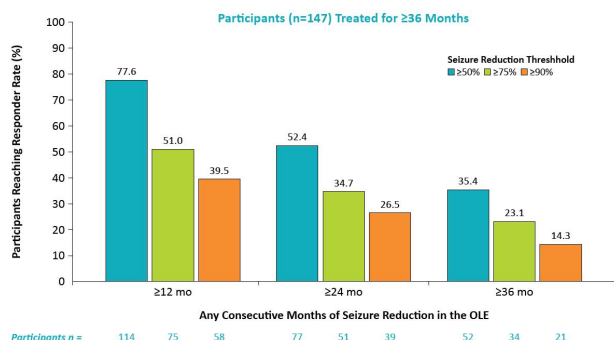
资料来源: 瑞替加滨 FDA 说明书, 华源证券研究所

图表 9: 持续 12/24/36 月以上癫痫发作频率 (50%/75%/90%) 降低患者占比 (所有进入 OLE 的患者)



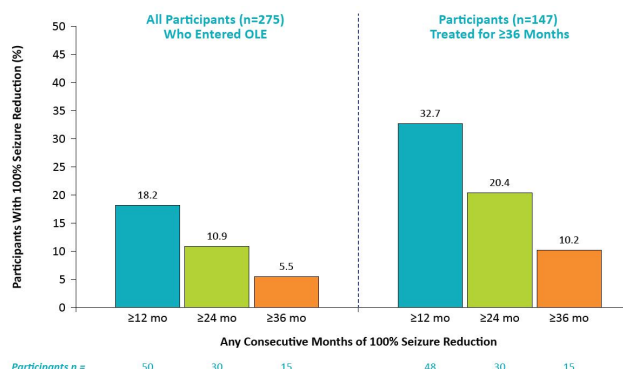
资料来源: 瑞替加滨 FDA 说明书, 华源证券研究所

图表 10: 持续 12/24/36 月以上癫痫发作频率 (50%/75%/90%) 降低患者占比 (完成 36 个月以上治疗患者)



资料来源: 瑞替加滨 FDA 说明书, 华源证券研究所

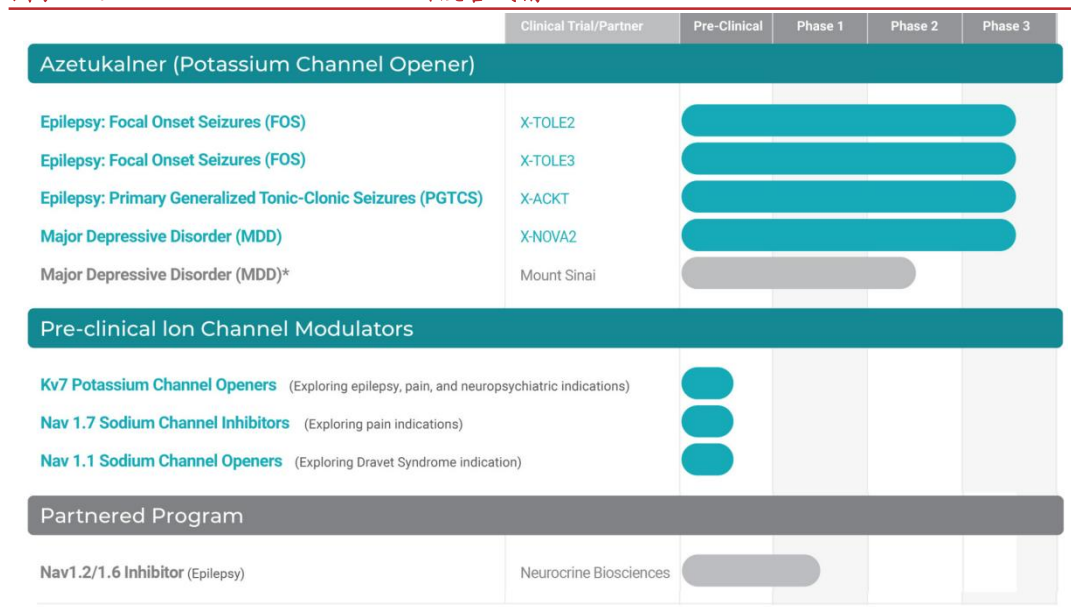
图表 11: 持续 12/24/36 月以上癫痫发作频率降幅达到 100% 患者占比情况



资料来源: 瑞替加滨 FDA 说明书, 华源证券研究所

目前 Xenon Pharmaceuticals 公司研发管线中仅有 Azetukalner 进入临床阶段，其他处于临床前阶段，除了癫痫适应症以外，Azetukalner 目前还在开展重度抑郁的临床三期试验，截至 2025 年 4 月 27 日，Xenon Pharmaceuticals 市值约为 29 亿美元。

图表 12: Xenon Pharmaceuticals 研发管线情况



资料来源: Xenon 公司官网, 华源证券研究所

海外研发进度方面，KCNQ 通道激动剂目前开发癫痫适应症的在研产品数量较少，除了 Xenon 公司处于临床 3 期外，仅有 Biohaven 公司的 BHV-7000 (KB-3061) 处于临床 2/3 期，以及挚盟医药的 CB03-154 处于临床二期。

图表 13: 全球治疗癫痫的 KCNQ 通道激动剂研发管线情况

NCT 号	试验分期	试验状态	试验用药	申办方	靶点	适应症	试验更新日期
NCT06612775	II 期	尚未招募	CB03-154	Shanghai Zhimeng Biopharma, Inc.	Kv7.2; Kv7.3	癫痫局灶性发作	2024-09-25
NCT06425159	II/III 期	招募中	KB-3061	Biohaven Therapeutics Ltd.	Kv7.2; Kv7.3	癫痫全身强直-阵挛发作	2025-04-16
NCT05716100	III 期	招募中	Azetukalner	Xenon Pharmaceuticals Inc.	Kv7	癫痫局灶性发作	2025-04-08

资料来源: 医药魔方, 华源证券研究所

国内方面，目前处于临床阶段的 KCNQ 通道激动剂仅有上海药物所和海南海药合作开发的派恩加滨目前处于临床二期阶段，以及纽欧申医药与丽珠集团合作开发的 NS-041 完成临床一期、即将开始二期患者入组。

图表 14: 中国治疗癫痫的 KCNQ 通道激动剂研发管线情况

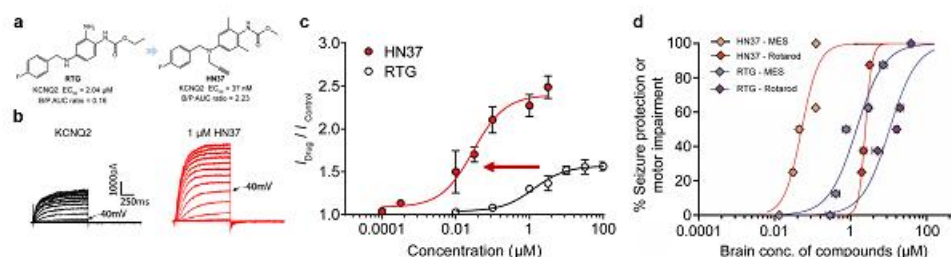
登记号	试验分期	试验状态	靶点	适应症	主试验药	申办方	首次公示日期
-----	------	------	----	-----	------	-----	--------

CTR2024 4520	Phase I	进行中(招募 完成)	Hedgehog; fungal CYP51; Kv7.3; Kv7.2	癫痫	NS-041	纽欧申医药(上海) 有限公司	2024-1 1-29
CTR2024 1138	Phase II	进行中(招募 中)	Kv7	癫痫局灶性发作	派恩加滨	中国科学院上海 药物研究所	2024-0 4-23

资料来源：医药魔方，华源证券研究所

派恩加滨 (HN37) 由上海药物所自主研发，与瑞替加滨相比，派恩加滨化学性质、活性、药代和安全性特征均显著优化，没有色素沉积风险，在包括难治性癫痫在内的多种动物模型上显示良好抗癫痫效应。

图表 15：派恩加滨对比瑞替加滨情况



资料来源：中国科学院上海分院官网，华源证券研究所

2019 年 6 月，海南海药与上海药物所达成合作，海南海药独家获得派恩加滨项目在中国大陆范围内的临床开发、生产、制造及商业化的权利，获得该项目技术相关发明专利在中国大陆地区的独占实施权，目前派恩加滨正在国内开展临床二期试验。

2. 伴自杀抑郁症治疗需求尚未满足，新药市场潜力可期

抑郁症严重威胁公众健康，全球百亿美元市场空间。抑郁症是常见的精神障碍，据医药魔方预测，美国 2025 年/2030 年抑郁症患者总数分别为 2092.5/2178.3 万人；而在中国，2014 年抑郁症患者总数达 3857.7 万人，其中重度抑郁症患者达 2250.3 万人。根据 Research and Markets 报告分析，全球抗抑郁药市场在 2022 年预计 145 亿美元，预计到 2030 年将达 176 亿美元。抑郁症在情感、躯体、认知等多方面消磨患者的生存意志，极易导致患者出现自杀相关的想法及行为，这种情况被称为伴有自杀意念或行为的抑郁症 (MDSI)。

每 2 位抑郁症患者就有 1 位有过自杀念头，MDSI 为精神科急症需立即干预。据《Prevalence of suicidal behaviors in patients with major depressive disorder in China: A comprehensive meta-analysis》统计，国内抑郁症患者出现自杀意念的比例高达 53.1%，实施过自杀计划的比例为 17.5%。在抑郁障碍患者群体中，最终有 10%~15% 的人死于自杀，

甚至出现“扩大性自杀”行为，即患者在杀死亲人后选择自杀，这种行为不仅严重危及患者自身的生命安全，也给家庭和社会带来了巨大的伤害。此外，MDSI 患者通常抑郁发作持续时间更长、相关症状更重，治疗反应更差，再入院风险也更高，患者医疗负担较重。

传统抗抑郁药种类繁多，但起效时间长，难以满足急救需求。传统抗抑郁药物出现于上世纪 50 年代，主要以单胺类物质、五羟色胺类物质为主。然而传统的抗抑郁药物常需要数周到数月才能开始改善情绪，起效慢难以解决 MDSI 患者急性发作问题，而且只能治愈 30%左右的抑郁症患者。

图表 16：常见抗抑郁药情况一览

药品名称	药物特点	常见不良反应及注意事项	作用机制
西酞普兰/ 艾司西酞普兰	适用于合并焦虑症状的抑郁症	恶心、呕吐、消化不良、腹泻、出汗、激越、焦虑、头痛、失眠、震颤、性功能下降、低钠血症、皮肤出血等，可发生撤药症状	5-羟色胺再摄取抑制剂 (SSRIs)
氟西汀	轻度抑制食欲，一般不引起体重增加	恶心、呕吐、消化不良、出汗、震颤等，同西酞普兰，但更易出现失眠和激越；注意可能改变胰岛素需求量	5-羟色胺再摄取抑制剂 (SSRIs)
帕罗西汀	治疗伴有焦虑症状的抑郁症效果佳	同西酞普兰，但抗胆碱能、镇静作用、撤药反应更常见	5-羟色胺再摄取抑制剂 (SSRIs)
舍曲林	具有改善认知的功能	同西酞普兰	5-羟色胺再摄取抑制剂 (SSRIs)
氟伏沙明	具有改善睡眠的作用	同西酞普兰，但恶心更常见	5-羟色胺再摄取抑制剂 (SSRIs)
文拉法辛	高剂量时抗焦虑	恶心、失眠、口干、嗜睡、便秘等，注意大剂量使用会引起血压升高，尽量使用最小有效剂量	5-羟色胺与去甲肾上腺素再摄取抑制剂 (SNRIs)
度洛西汀	可用于伴有躯体疼痛的抑郁症	恶心、失眠、头痛、口干、便秘等，注意可升高血压，提高心率	5-羟色胺与去甲肾上腺素再摄取抑制剂 (SNRIs)
安非他酮	可用于性功能障碍	注意高剂量时增加惊厥风险	去甲肾上腺素及多巴胺再摄取抑制剂 (NDRI)
阿戈美拉汀	改善睡眠	肝功能异常慎用	褪黑激素受体 MT1 和 MT2 激动剂和 5-羟色胺受体 5-HT2C 拮抗剂
米氮平	对食欲和睡眠有改善作用，对性功能影响小	食欲增加、体重增加、困倦、水肿、白细胞减少等，注意监测血糖	去甲肾上腺素能和特异性 5-羟色胺能抗抑郁药
阿米替林	对焦虑和抑郁都有明显效果	不良反应较多，如心律失常、低血压、性功能障碍、谵妄等，需定期检查心电图	三环类抗抑郁药 (TCAs)

资料来源：丁香园精神时间公众号，华源证券研究所

指南推荐电击疗法用于 MDSI 一线治疗，但恐惧心理、电击后记忆丢失使其存在一定应用限制。改良无抽搐电休克治疗 (MECT) 被指南推荐为有自杀意念或行为的抑郁症患者的一线治疗。然而，MECT 需全身麻醉及全阶段护理，部分患者对 MECT 治疗存在恐惧心理，电击也可能导致记忆障碍。

综上所述，对于伴有急性自杀意念或行为的抑郁症患者而言，临床实践中迫切需要一种起效更为迅速、疗效更为确切、耐受性更佳且操作便捷易行的治疗手段。

2.1. 强生 Spravato：唯一 MDSI 药物疗法，销售峰值至少 30 亿美元

全球唯一 MDSI 药物疗法，艾司氯胺酮是新机制、超速效抗抑郁药物。强生制药的盐酸艾司氯胺酮鼻喷雾剂 (速开朗, Spravato) 是全球首个且唯一一款伴急性自杀意念或行为抑郁症患者用药。艾司氯胺酮的有效成分是氯胺酮的右旋异构体 (S 构型)，通过拮抗 NMDA

受体受体发挥抗抑郁作用，为 30 年以来首款全新作用机制治疗抑郁症药品。临床研究证实，联合口服抗抑郁药，患者 最早在用药 4 小时后即观察到治疗获益，且 24 小时内获得缓解的患者数是标准治疗的 2 倍。

Spravato 最新年销售额 10 亿美金，处于高速放量阶段；强生对该药寄予厚望，预期 2027 年销售额至少 30 亿美金。2019 年 3 月，艾司氯胺酮在美国获批上市，联合一种口服药用于难治性抑郁；2020 年，获 FDA 批准可以与口服抗抑郁药联合应用治疗 MDSI。2025 年 1 月 21 日，FDA 批准单药治疗 TRD，成为美国首个获批的治疗成人 TRD 的单药疗法。2023 年 4 月 20 日，获得 CDE 批准，用于与口服抗抑郁药联合治疗 MDSI。2024 年 Spravato 全球销售额 10.77 亿美金，同比增速 56.4%，其中美国销售占比 86%。

成瘾性使其应用场景受限，安全性更佳的下一代产品需求迫切。艾司氯胺酮鼻喷雾剂具有强效的药理作用，具有一定的成瘾性、副作用，在我国按照第一类精神药品进行管理。它对适用人群和用药过程都有严格要求。出于防止滥用和安全性的考虑，作为一类精神药品，该药必须在医护人员的直接监督下才能使用，仅限在医疗机构内使用。

艾司氯胺酮仿制药已经上市，但抑郁症尚未过专利期，现仿制药均为麻醉适应症、注射剂型。

2.2. 华纳药厂 ZG001：改构氯胺酮，无成瘾性，有望颠覆抑郁症治疗格局

改构自氯胺酮，ZG001 革除成瘾性副作用。ZG-001 是一种以氯胺酮为基础进行结构改造而得到的新一代抗抑郁候选药物。非临床研究结果显示，ZG-001 口服给药具有与氯胺酮相当的抗抑郁效果，同时革除了氯胺酮的药物依赖、拟精神病样等严重精神副作用。

口服抗抑郁，进一步加强用药便利性，临床 1 期验证无成瘾性副作用。健康受试者临床 I 期研究结果显示 ZG-001 口服代谢性质良好，暴露量水平随给药剂量的增加而增加，无性别差异，无蓄积；安全性优异，未发现 2 级及以上不良事件，未见药物依赖、分离等精神副作用。

已开临床 2 期，上月底首例入组。首都医科大学附属北京安定医院及首都医科大学附属北京安定医院芜湖医院两家研究中心开展名为“ZG-001 胶囊治疗伴自杀意念或行为的重性抑郁障碍”的 IIa 期临床研究，该研究已于 2025 年 3 月 24 日成功完成首例受试者的入组。

3. 行业观点：坚持创新+出海+老龄化主线，关注国内政策修复

本周（4.21-4.25）、年初至今医药指数涨跌幅分别为+1.16%和-0.31%，相对沪深300指数的超额收益分别为0.77%和3.45%。

个股情况：本周上涨个股数量311家，下跌个股174家，涨幅居前为永安药业（+31.37%）、舒泰神（+28.41%）、尔康制药（+27.73%）、富士莱（+23.89%）和卫信康（+21.00%），跌幅居前为*ST吉药（-43.24%）、南华生物（-35.29%）、双成药业（-27.74%）、荣丰控股（-21.24%）和爱博医疗（-19.07%）。

图表 17：本周申万医药行业涨幅 Top10

排序	代码	名称	市值（亿元）	本周表现	本月至今表现	年初至今表现
1	002365.SZ	永安药业	34.9	31.37%	43.12%	48.31%
2	300204.SZ	舒泰神	55.7	28.41%	62.62%	57.35%
3	300267.SZ	尔康制药	62.7	27.73%	17.37%	9.35%
4	301258.SZ	富士莱	26.8	23.89%	18.65%	23.62%
5	603676.SH	卫信康	49.7	21.00%	16.19%	14.67%
6	001367.SZ	海森药业	33.1	18.84%	15.56%	18.36%
7	301103.SZ	何氏眼科	33.9	18.00%	8.50%	6.56%
8	603351.SH	威尔药业	37.8	16.25%	7.35%	13.60%
9	300391.SZ	*ST长药	17.3	15.73%	-10.36%	-2.18%
10	688192.SH	迪哲医药-U	260.0	15.51%	15.51%	36.48%
11	801150.SI	医药生物(申万)		1.16%	-2.55%	-0.31%
12	000300.SH	沪深300		0.38%	-2.58%	-3.76%

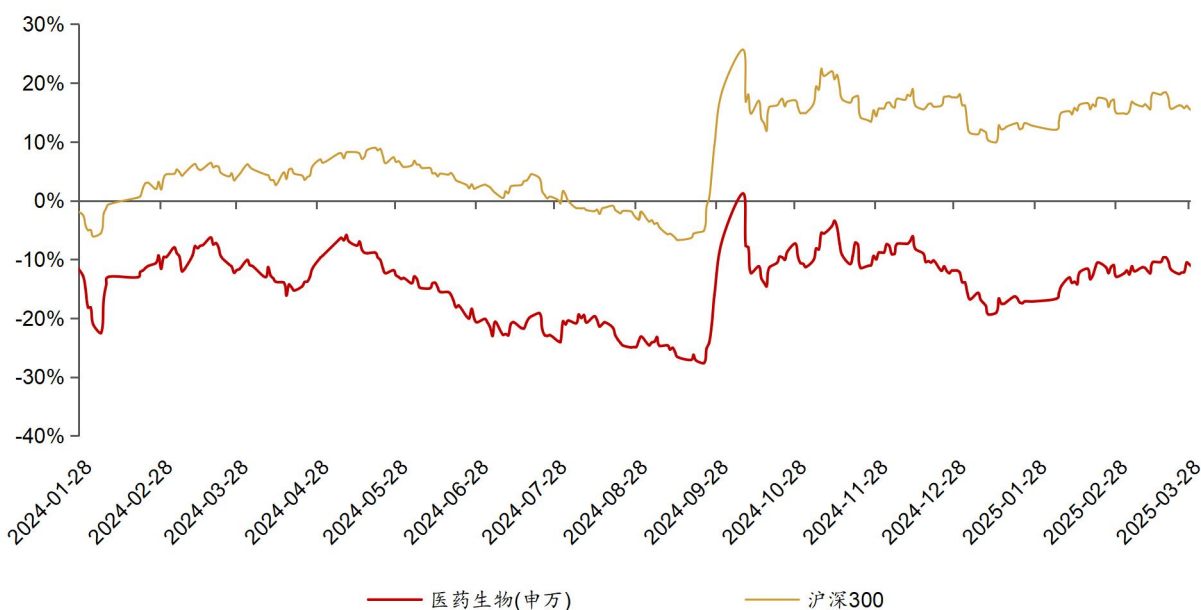
资料来源：Wind，华源证券研究所

图表 18：本周申万医药行业跌幅 Top10

排序	代码	名称	市值（亿元）	本周表现	本月至今表现	年初至今表现
1	300108.SZ	*ST吉药	1.4	-43.24%	-77.66%	-83.59%
2	000504.SZ	南华生物	19.7	-35.29%	-37.33%	-28.62%
3	002693.SZ	双成药业	39.3	-27.74%	10.49%	-48.28%
4	000668.SZ	荣丰控股	7.1	-21.24%	-3.41%	-25.04%
5	688050.SH	爱博医疗	154.7	-19.07%	-16.69%	-10.33%
6	300326.SZ	凯利泰	34.7	-16.84%	-21.56%	-25.54%
7	300841.SZ	康华生物	70.0	-16.57%	-14.05%	-3.41%
8	600200.SH	江苏吴中	28.1	-15.24%	-25.33%	-57.62%
9	002581.SZ	未名医药	49.0	-11.46%	-21.31%	-30.26%
10	002750.SZ	*ST龙津	4.5	-11.02%	-20.42%	-48.40%
11	801150.SI	医药生物(申万)		1.16%	-2.55%	-0.31%
12	000300.SH	沪深300		0.38%	-2.58%	-3.76%

资料来源：Wind，华源证券研究所

图表 19：2024 年初至今医药指数表现



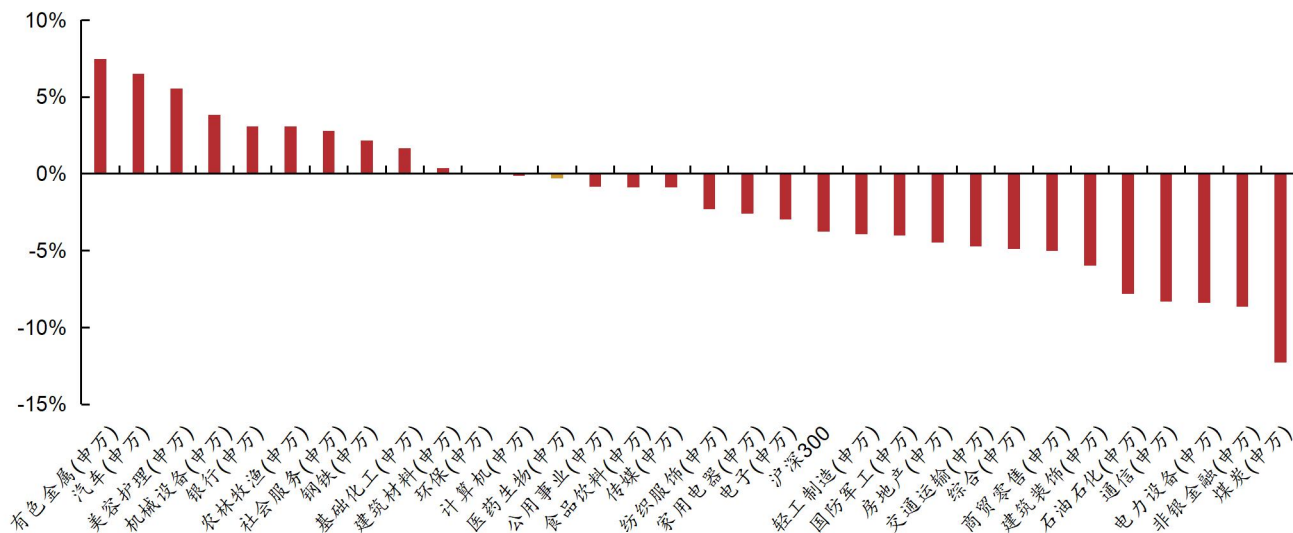
资料来源：Wind，华源证券研究所

细分赛道涨跌幅情况：

本周，化学原料药（+4.7%）、医疗服务（+3.4%）、化学制剂（+2.3%）、医疗器械（+0.2%）、医药商业（-0.3%）、中药（-0.5%）、生物制品（-0.9%）。

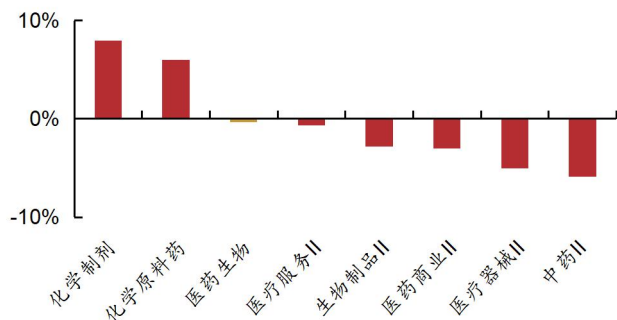
年初以来，化学制剂（+8.0%）、化学原料药（+6.0%）、医疗服务（-0.7%）、生物制品（-2.8%）、医药商业（-3.0%）、医疗器械（-5.0%）、中药（-5.9%）。

图表 20：申万各板块年初至今涨跌幅情况



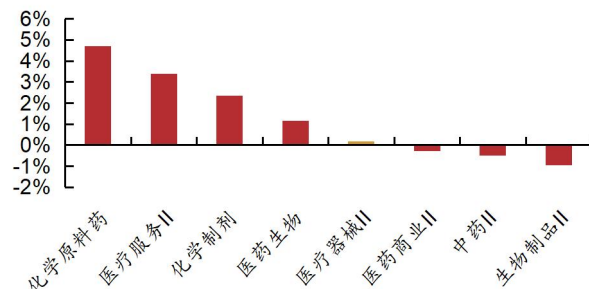
资料来源：Wind，华源证券研究所

图表 21：年初至今医药子板块涨跌幅情况



资料来源：Wind，华源证券研究所

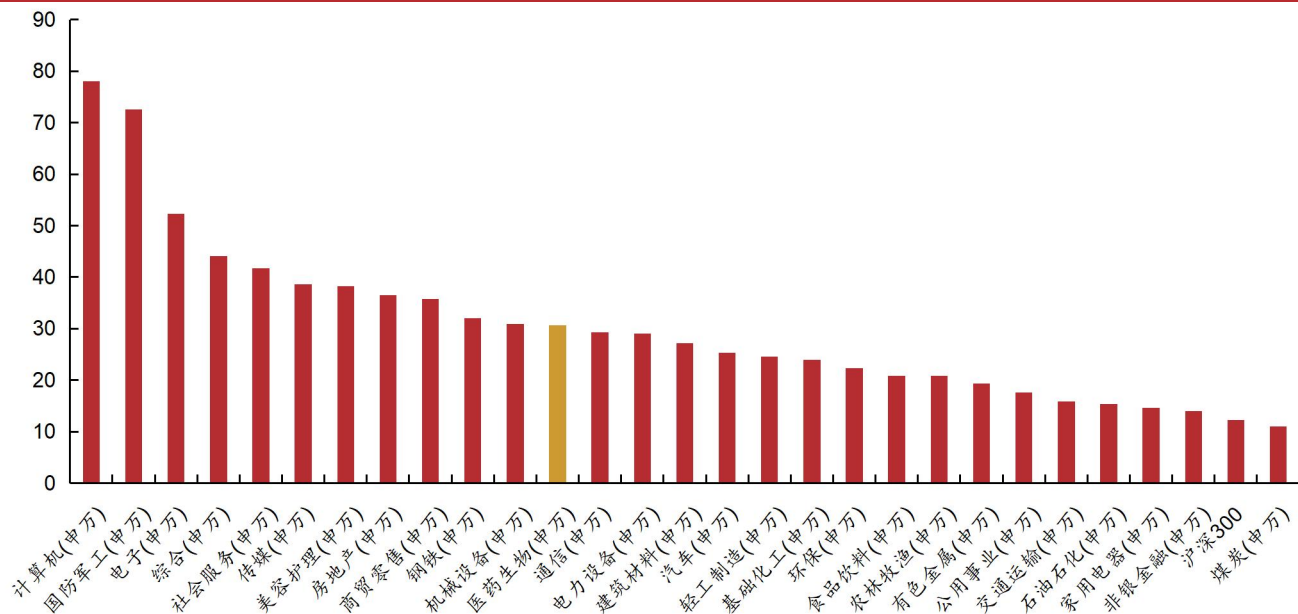
图表 22：本周医药子板块表现情况



资料来源：Wind，华源证券研究所

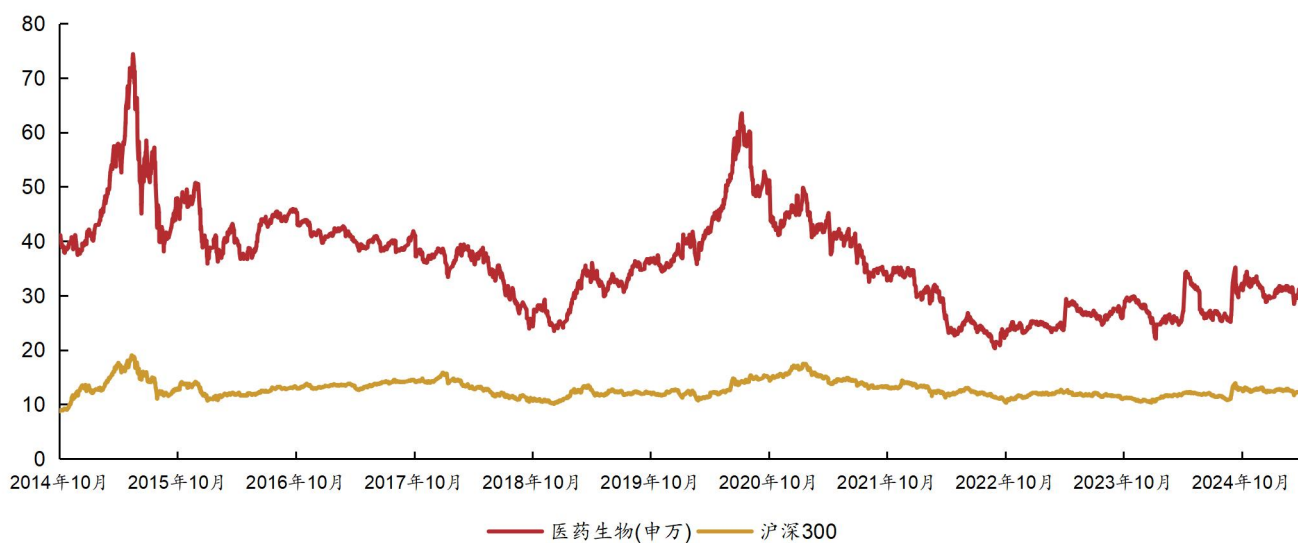
板块估值：截至 2025 年 4 月 25 日，申万医药板块整体 PE 估值为 30.67X，在申万一级分类中排第 12，从 PE 绝对值来看，目前医药估值仍在历史相对较低位置。各细分板块估值情况，目前化学制剂、化学原料药和医疗服务等板块估值相对较高，医药商业和中药估值相对较低。

图表 23：申万各板块 PE 估值情况（截至 2025 年 4 月 25 日，整体 TTM 法）



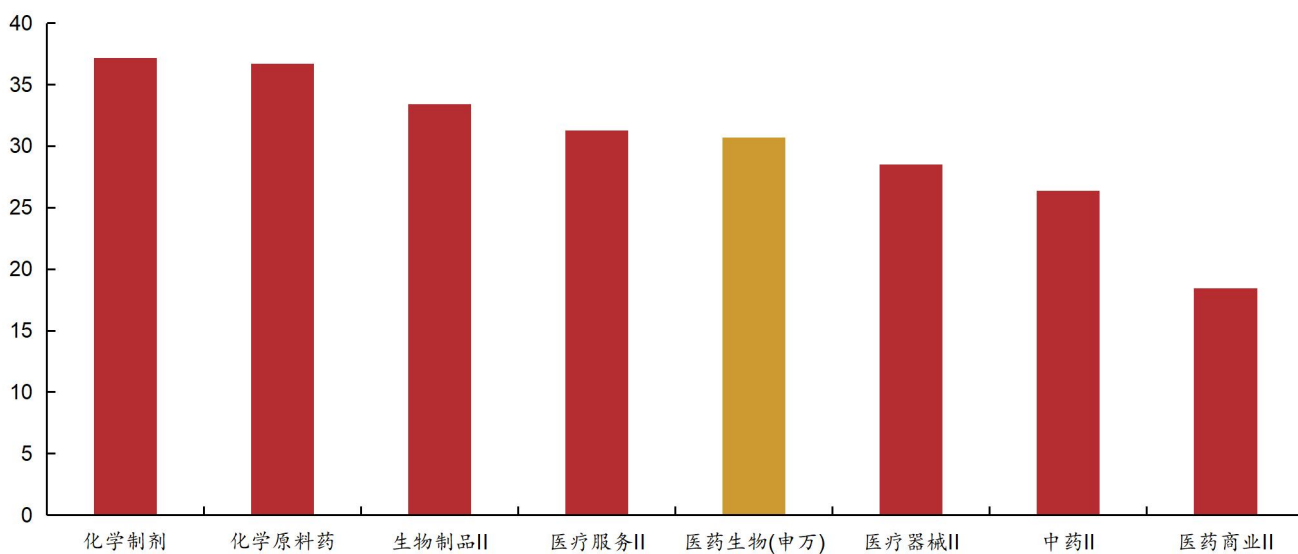
资料来源：Wind，华源证券研究所

图表 24：申万医药及沪深 300 PE 估值情况（截至 2025 年 4 月 25 日，整体 TTM 法）



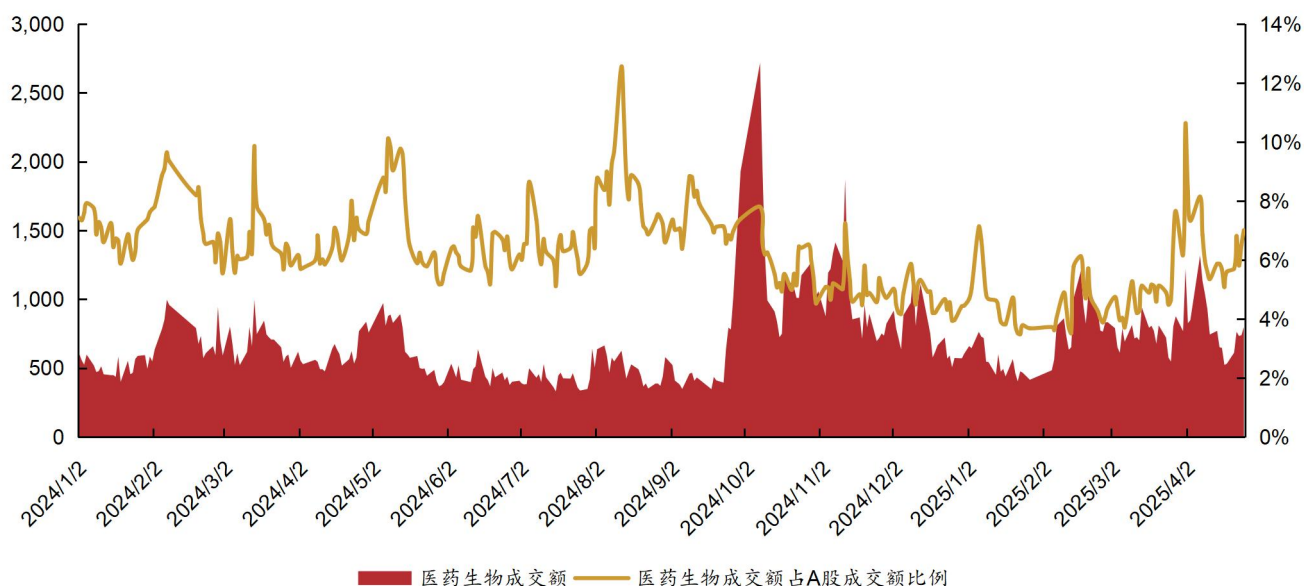
资料来源：Wind，华源证券研究所

图表 25：申万医药各细分板块 PE 估值情况（截至 2025 年 4 月 25 日，整体 TTM 法）



资料来源：Wind，华源证券研究所

图表 26：2024 年初至今医药成交额及占 A 股比例（万亿）



资料来源：Wind，华源证券研究所

投资观点：2024 年医药指数下跌超 14%，我们认为核心原因是新一轮医改进入深水区、政策扰动加速、企业成长动能转换带来阵痛所致，其中行业整顿持续进行，院内 DRG/DIP 进一步推广，院外医保品种政策调整，以及集采持续扩面等。当前位置，我们认为医药已经呈现多重底，医改影响或逐步调整到位，板块估值、持仓均处于近年来低位，业绩也有望迎来企稳回升。具体来看，目前医药板块整体 PE 估值处于历史较低位置。展望 2025 年，我们认为医药具备多方面的积极发展因素，1）创新产业已经初具规模，多家公司的创新布局迎来收获，传统 pharma 也已经完成创新的华丽转身；2）出海能力持续提升，创新药械的 license out 频频出现，中国企业已成为全球 MNC 非常重视的创新转换来源；3）老龄化持续加速，银发经济长坡厚雪；4）支付端看，医保收支仍在稳健增长，同时医保局积极推动商业保险的发展，构建多层次支付体系；5）AI 浪潮下，医药有望迎来新发展机遇，释放新的增长潜力。

整体来看，我们认为当前医改影响或逐步调整到位，行业有望边际好转，看好 2025 年医药否极泰来，结构性高增长的细分领域和个股值得期待。当前位置适合战略性布局，坚持“创新+出海+老龄化”主线，重点布局低估资产，建议关注以下方向：

1）创新药械及产业链：国务院明确表态支持创新药全产业链发展，多地陆续出台相关政策，我们认为创新药/械及产业是较为明确的产业趋势，建议关注恒瑞医药、科伦药业、信立泰、科伦博泰、康方生物、和黄医药、翰森制药、中国生物制药、三生制药、信达生物、泽璟制药、热景生物、科兴制药、广生堂、赛诺医疗等。产业链方面，建议关注药明康德、药明生物、药明合联、凯莱英、泰格医药、百普赛斯、毕得医药等。

2）出海：欧美占据全球医药主要市场份额，市场空间大，新兴市场正在快速发展，海外潜在增量十分可观，建议关注迈瑞医疗、联影医疗、华大智造、鱼跃医疗、三诺生物、美好医疗、海泰新光、科兴制药等。

3) 国产替代: 国产替代依旧是未来几年较为确定的产业趋势, 其中内窥镜、微电生理等市场空间大、竞争格局好、国产率低, 主要建议关注开立医疗、澳华内镜、惠泰医疗、微电生理等。

4) 老龄化及院外消费: 随着 50 岁以上的老年化群体持续扩大, 相关的健康消费需求有望稳步增长, 建议关注昆药集团、鱼跃医疗、可孚医疗、华润三九、同仁堂、马应龙、羚锐制药、盘龙药业等。

5) 高壁垒行业: 麻药和血制品行业需求较为稳健, 供给端相对稳定, 建议关注麻药 (人福医药、恩华药业、国药股份等)、血制品 (派林生物、天坛生物、博雅生物等)。

6) 小而美标的: 随着市场情绪显著好转, 部分前期估值受到压制、但业绩稳健或高增长公司有望迎来估值修复, 建议关注百洋医药、普门科技、盘龙药业、方盛制药、立方制药、麦澜德等。

7) AI 主线或有望贯穿 2025 年, 医药相关板块和个股有望反复表现, 建议关注制药 (晶泰控股、泓博医药)、大数据模型 (润达医疗、美年健康、金域医学、医脉通、阿里健康、华大基因)、医疗设备 (鱼跃医疗、三诺生物、联影医疗、开立医疗、华大智造) 等。

本周建议关注组合: 信立泰、一品红、华纳药厂、开立医疗、方盛制药;

四月建议关注组合: 中国生物制药、三生制药、科伦博泰、科伦药业、一品红、科兴制药、热景生物、人福医药、健民集团、昆药集团。

4. 风险提示

1) 行业竞争加剧风险：随着我国医药产业的不断创新与进步，不排除持续有新进竞争者加入从而造成竞争加剧的风险；

2) 政策变化风险：分级诊疗、医保支付改革持续成为医改重心，医保控费大趋势、带量采购等让医药产业中下游的收入利润有承压风险；

3) 行业需求不及预期风险：若终端需求不及预期，将会对公司业绩产生负面影响。

证券分析师声明

本报告署名分析师在此声明，本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，本报告表述的所有观点均准确反映了本人对标的证券和发行人的个人看法。本人以勤勉的职业态度，专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观的出具此报告，本人所得报酬的任何部分不曾与、不与、也不将会与本报告中的具体投资意见或观点有直接或间接联系。

一般声明

华源证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。

本报告是机密文件，仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司客户。本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测等只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特殊需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

本报告所载的意见、评估及推测仅反映本公司于发布本报告当日的观点和判断，在不同时期，本公司可发出与本报告所载意见、评估及推测不一致的报告。本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现，过往的业绩表现不应作为日后回报的预示。本公司不承诺也不保证任何预示的回报会得以实现，分析中所做的预测可能是基于相应的假设，任何假设的变化可能会显著影响所预测的回报。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式修改、复制或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。如征得本公司许可进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“华源证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

本公司销售人员、交易人员以及其他专业人员可能会依据不同的假设和标准，采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论或交易观点，本公司没有就此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

信息披露声明

在法律许可的情况下，本公司可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。本公司将会在知晓范围内依法合规的履行信息披露义务。因此，投资者应当考虑到本公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

投资评级说明

证券的投资评级：以报告日后的 6 个月内，证券相对于同期市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入：相对同期市场基准指数涨跌幅在 20% 以上；

增持：相对同期市场基准指数涨跌幅在 5% ~ 20% 之间；

中性：相对同期市场基准指数涨跌幅在 -5% ~ +5% 之间；

减持：相对同期市场基准指数涨跌幅低于 -5% 及以下。

无：由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级。

行业的投资评级：以报告日后的 6 个月内，行业股票指数相对于同期市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好：行业股票指数超越同期市场基准指数；

中性：行业股票指数与同期市场基准指数基本持平；

看淡：行业股票指数弱于同期市场基准指数。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；

投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。

本报告采用的基准指数：A 股市场基准为沪深 300 指数，香港市场基准为恒生中国企业指数（HSCEI），美国市场基准为标普 500 指数或者纳斯达克指数。